

健康医院急诊分诊与绿色通道须知

向量检索联调测试资料

本须知说明急诊入口、分诊顺序、危急症状和绿色通道。急诊按病情紧急程度安排诊疗，并不按照到院先后顺序排队。

需要立即就医的情况

- 持续胸痛、胸闷并伴有大汗、呼吸困难或濒死感。
- 突发口角歪斜、单侧肢体无力、言语不清或意识障碍。
- 严重外伤、大量出血、抽搐不止、重度过敏或明显呼吸困难。
- 孕产妇大量出血、剧烈腹痛，或者儿童出现持续高热伴精神反应差。

上述情况应立即拨打 120

或前往急诊，不要等待普通门诊号源，也不要仅依赖线上咨询。夜间急诊入口设在医院东门，二十四小时开放。

急诊分诊级别

级别	病情说明	安排原则
一级	濒危，生命体征不稳定	立即抢救
二级	危重，可能快速恶化	优先诊疗
三级	急症，生命体征相对稳定	按病情候诊
四级	非急症或轻症	依序候诊，可建议门诊

绿色通道

对疑似急性心肌梗死、急性脑卒中、严重创伤、危重孕产妇和危重新生儿，分诊人员评估后启动绿色通道。患者先接受必要的抢救、检查和会诊，身份登记与费用手续可由家属随后补办。绿色通道不等同于免除医疗费用。

陪同与秩序

抢救区域原则上只允许一名家属配合沟通，其他人员应在指定区域等候。患者和家属不得自行进入抢救室或干扰分诊。若候诊期间症状加重，应立即告知分诊护士，护士会重新评估分诊级别。

建议测试问题

- 晚上突然胸口疼应该从哪里进入医院
- 急诊是不是先到的人先看
- 什么情况可以走急诊绿色通道
- 候诊时病情加重应该怎么办